

21- Resume de La Structuration Vasculaire par La Cavite Amiotique

L'origine de mon système vasculaire, la périphérie, est aussi fortement intégrée dans le système vitellin. En même temps, j'ai ma cavité amniotique. A la fois, j'ai cette cavité amniotique qui est aussi grande au départ que ma vésicule vitelline. L'embryon va grandir énormément, va s'allonger. Et là, on voit, regardez comme l'importance de cette cavité vient intégrer tout mon système vitellin. Tu vois, il vient complètement s'emballer. Ça, c'est le mouvement que je veux qu'on travaille aujourd'hui. C'est dans ce mouvement que, tu vois, tout ce système vitellin se résorbe vers le centre de l'embryon. Tu vois, c'est tout ce mouvement qu'il réintègre. Et donc, c'est cette cavité amniotique, cette zone B comme moi je l'appelle, en rapport avec mon système aortique, qui réaspire tout vers le centre. A la fois sur un plan transversal abdominal et thoracique. Petit à petit, la croissance, la mise en place du cœur, avec la croissance énorme du cerveau, le mouvement, cette fois-ci, de ma cavité amniotique, tu vois, qui vient complètement tout prendre. Elle va prendre tout l'espace de ce qu'on appelle le cellulome externe. Il y a juste une partie de ce cellulome interne qui sera intégrée en un cellulome interne. Tu vois, cette cavité amniotique, en fait, ça va s'arrêter, mais on va voir qu'elle va encore grandir, grandir, grandir. Et vous voyez, plus elle grandit, plus ceci s'intègre. Regardez encore ici. Ça, c'est le résumé sur deux dias de toute l'intégration de votre système artériel, c'est-à-dire l'intégration de votre système artériel depuis la périphérie vers le centre, c'est-à-dire céphalisation qui entraîne la cardialisation, qui entraîne la diaphragmatisation, l'hépatisation, et donc c'est tout l'enroulement comme ça. La tête est ici et là, j'ai ma cavité amniotique. Et la cavité amniotique, elle fait quoi ? Elle fait ça. Regardez le dessin. Vous revenez sur ma main. Regardez le dessin. Vous revenez sur ma main. Elle va complètement intégrer tout ça. Donc elle va redélimiter. Et dans cette face-là, aussi bien comme ça que comme ça, j'ai la construction de ma zone B. Et donc c'est comme

si la vésicule viteline qui contenait l'information primitive au plan veineux fait comme ça. Au même moment, j'ai l'extérieur qui fait comme ça. Et la combinaison des deux réintègre mon corps. Et mon système veineux à l'intérieur. Le secret, c'est ramener les fluides vers le centre, que c'est le système facial qui est prépondérant pour la libération. Troisième chose, c'est ma vésicule viteline qui contient une grande source d'information. Et ça, c'est le mouvement d'intégration à la fois du cellulome externe en un cellulome interne, fermeture du tube neural, et toute l'intégration et tout le mouvement qui vient se réintégrer vers le centre. Et toute la construction ici qui est donnée par ma cavité. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est redonner cette cavité, redonner cette zone B, pour réintégrer ta circulation à l'intérieur. Là, j'ai disposé la DIA, tu vois, pour la mettre comme si j'avais une personne couchée ici, allongée. Le schéma, il faut juste le retourner par rapport au film. En bleu, ici, ce sera l'intégration en un tube neural, et le reste va former la peau ici, tu vois, qui est une couche ectodermique. Puis, au même moment que j'ai ce mouvement-ci, j'ai l'intégration de ma vésicule vitéline, pour former une partie qu'on va appeler le système digestif, mais au même moment, j'ai toute l'intégration de mon système veineux. Le mouvement à suivre pour nous, c'est un mouvement qui se développe avec ma cavité amniotique, comme elle grandit ici, comme elle grandit, et puis à un moment donné, il y a une fusion qui va se faire pour former la partie longitudinale, le tube digestif. Et ici, l'intégration, je l'ai dessiné en jaune ici, pour montrer l'intégration du cellulome externe en un cellulome interne futur, où ceci va se rejoindre sur la ligne médiane, tu vois, comme ceci. Donc, j'ai à la fois le grand moteur pour tout ça, c'est mon système notochordal, qui influence mon tube neural, qui organise mon système vasculaire primitif aortique, qui redirige toute l'information avec l'intégration petit à petit de tout ce système transversal, depuis la périphérie vers

le centre, et donc, tout ce mouvement. Je visualise ça, et j'ai ceci. Et nous, ce qu'on va faire, c'est suivre petit à petit ce mouvement-là. Exagère ! Il faudra juste mettre les mains et laisser faire la respiration primaire. Et je vais vous guider là-dedans. A la fois, ça va être une réintégration de votre système vasculaire, et à la fois, ça va être la protection de votre zone B, si tu veux, et qui est toujours là, mais sous une autre forme. Alors, le mouvement endovolontal des poumons, il part de l'endoderme, et en fait, lui, il va faire un mouvement comme ça. Mais c'est quand même orienté par le système vasculaire aussi. Alors, en fait, la conscience du pédicule ombilical, elle doit revenir dans cet espace-ci. Parce que c'est comme ça que tu vois que j'ai la force de la cavité amniotique qui grandit, mais qui a, en même temps, le processus de céphalisation, cardialisation, diaphragmatisation, hépatisation. Et puis, j'ai tout le retour comme ça. Et c'est là que ma vésicule viteline, poussée par la vitesse de croissance différentielle à la partie inférieure par rapport à mon allantoïde, qui va être reprise dans le schéma et qui vient repousser le pédicule qui est ici pour rejoindre ma vésicule viteline pour former plus tard le cordon ombilical. Tout va se rejoindre ici. On part d'une certaine façon sur son pédicule et on revient sur un cordon.